

Poliposis nasal

1. Introducción y relevancia clínica

La **poliposis nasal** es una enfermedad inflamatoria crónica de la mucosa de las cavidades nasales y senos paranasales caracterizada por la **formación de pólipos benignos**, que son **proyecciones edematosas** de la mucosa respiratoria.

Afecta aproximadamente al **2–4% de la población**, con mayor prevalencia en hombres adultos y en pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, especialmente **asma** y **rinosinusitis crónica (RSC)**.

Relevancia clínica

- Es una causa **frecuente de obstrucción nasal bilateral persistente**, anosmia e hiposmia.
 - Se asocia a **asma** y **sensibilidad a aspirina o AINEs** (tríada de Samter).
 - En Chile, su diagnóstico y manejo adecuado en Atención Primaria permite reducir la progresión a **rinosinusitis crónica complicada**.
 - Requiere manejo conjunto entre **medicina general, alergología y otorrinolaringología**.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Origen y mecanismos

Los pólipos nasales se originan por **inflamación crónica persistente** de la mucosa nasal y sinusal, con predominio de células **eosinófilas, mastocitos** y **linfocitos T CD4+**.

Mecanismos implicados

1. **Disfunción de la barrera epitelial:** favorece el ingreso de alérgenos, microorganismos o irritantes.
2. **Respuesta inflamatoria tipo Th2:** con liberación de IL-4, IL-5, IL-13 → eosinofilia local.

3. **Edema intersticial y remodelación tisular:** proliferación de fibroblastos y depósito de colágeno → formación del pólipo.
-

2.2 Factores de riesgo y asociaciones

- **Asma bronquial** (hasta en 30–40% de los casos).
 - **Sensibilidad a aspirina y AINEs (Tríada de Samter):** asma + poliposis + intolerancia a AAS.
 - **Rinitis alérgica o crónica.**
 - **Fibrosis quística** (especialmente en niños).
 - **Infecciones crónicas** o biofilm bacteriano (*S. aureus*).
 - **Alergia fúngica sinusal.**
-

2.3 Histología

Los pólipos están formados por epitelio respiratorio con **edema submucoso**, **glándulas seromucosas dilatadas**, y un **infiltrado inflamatorio eosinofílico**.

No tienen potencial maligno, pero pueden confundirse con neoplasias (ej. papiloma invertido).

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas principales

Los pólipos nasales suelen crecer lentamente y producir síntomas bilaterales.

Síntoma	Características
Obstrucción nasal	Progresiva, bilateral, persistente.

Hiposmia o anosmia	Muy característica.
Rinorrea	Mucosa o mucopurulenta.
Sensación de presión o plenitud facial.	Leve o moderada.
Alteración del gusto y ronquido.	Por obstrucción crónica.
En niños, pensar en fibrosis quística ante poliposis recurrente.	

3.2 Signos al examen físico

- **Pólipos visibles a la rinoscopía anterior o endoscopia:**
 - Lisos, translúcidos, pálidos, móviles, indoloros.
 - Originan habitualmente del **meato medio** (etmoides).
 - **Cornetes hipertrofiados** e inflamación mucosa coexistente.
-

3.3 Diagnóstico diferencial

Entidad	Características distintivas
Cornete medio hipertrofiado	Rosado, sensible, no translúcido.
Papiloma invertido	Lesión unilateral, irregular, friable.
Angiofibroma juvenil	Varones adolescentes, epistaxis recurrente.

Neoplasia maligna nasal

Unilateral, sangrado frecuente, masa dura.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

- Basado en síntomas ≥ 12 semanas (obstrucción, rinorrea, hiposmia) + evidencia endoscópica de pólipos.
 - Confirmado con estudios de imagen.
-

4.2 Endoscopía nasal

- Examen de elección en APS derivada a ORL.
 - Permite evaluar el tamaño, localización y extensión de pólipos.
 - Clasificación de **Lund-Kennedy** (0 a 2 por lado, según tamaño).
-

4.3 Tomografía computarizada (TAC) de senos paranasales

- Estudio de referencia.
- Permite evaluar extensión y compromiso sinusal.
- Clasificación de **Lund-Mackay** (0–24 puntos según opacificación).

Hallazgos típicos:

- Engrosamiento mucoso difuso.
- Opacificación completa de senos etmoidales y maxilares.
- Pólipos bilaterales en meato medio.

4.4 Estudios complementarios según sospecha

Examen	Indicaciones
Test de alergia o IgE específica	Sospecha de componente alérgico.
Test de sudor o genético	Niños con poliposis recurrente (descartar fibrosis quística).
Biopsia	Si lesión unilateral, irregular o sangrante (descartar tumor).

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

El manejo busca **reducir la inflamación, controlar los síntomas y prevenir recurrencias**.

Incluye **tratamiento médico** y, en casos refractarios, **quirúrgico**.

5.1 Tratamiento médico

A. Corticoides tópicos nasales (tratamiento de elección)

- Reducen tamaño de pólipos y síntomas.
- Ejemplos:
 - **Mometasona furoato:** 200 µg/día (1 puff c/fosa, 2 veces al día).
 - **Fluticasona propionato:** 100–200 µg/día por fosa.
 - **Budesonida:** 64 µg por fosa, 2 veces al día.

Duración mínima: **3 meses continuos**.

B. Corticoides orales (fase aguda o exacerbación)

- Indicados en poliposis extensa o con hiposmia severa.
 - **Prednisona 40 mg/día por 5–10 días** (sin sobrepasar 2 ciclos al año).
 - Siempre acompañar de corticoide nasal posterior.
-

C. Lavados nasales con solución salina hipertónica (3%)

- Favorecen limpieza mucosa y reducen edema.
 - Se indican 1–2 veces al día, permanentes.
-

D. Antihistamínicos orales

- Solo útiles si existe componente alérgico.
 - Ejemplo: **Loratadina 10 mg/día**.
-

E. Antileucotrienos (Montelukast 10 mg/día)

- Útiles en pacientes con **asma** o **tríada ASA**.
 - Pueden reducir recurrencias postquirúrgicas.
-

5.2 Tratamiento quirúrgico

Cirugía endoscópica funcional de senos paranasales (CEFS):

- Indicaciones:
 - Falta de respuesta al tratamiento médico ≥ 3 meses.
 - Obstrucción nasal severa con apnea del sueño.
 - Complicaciones orbitarias o intracraneales.

Objetivos:

- Eliminar pólipos y restaurar drenaje sinusal.
- Permitir mejor acceso del corticoide tópico.

Recurrencia:

Alta (40–60%), por lo que requiere **tratamiento médico de mantención continuo**.

5.3 Nuevas terapias (casos severos o refractarios)

- **Anticuerpos monoclonales anti-IL-5 y anti-IgE:**
 - **Mepolizumab** o **Omalizumab** aprobados para poliposis severa refractaria en combinación con asma eosinofílica.
 - Indicados por especialista, no disponibles en APS.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Obstrucción nasal crónica	Síntoma cardinal, causa ronquido o SAHOS.
Sinusitis crónica recurrente	Por obstrucción de drenaje.
Anosmia persistente	Frecuente, a veces irreversible.
Recurrencia postoperatoria	30–60% en 5 años, sobre todo en asmáticos.

Compromiso orbitario o cerebral (raro) En extensión masiva no tratada.

Pronóstico:

Bueno con manejo médico prolongado y seguimiento ORL.

Las recurrencias son comunes, pero se controlan con corticoides tópicos y lavados.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Poliposis nasal = obstrucción bilateral + anosmia + pólipos visibles.**
 2. Siempre descartar **fibrosis quística** en niños con pólipos.
 3. **Corticoides tópicos** son la base del tratamiento.
 4. En **tríada de Samter**, evitar aspirina y AINEs.
 5. **Recurrencia postquirúrgica** requiere terapia médica de mantención.
 6. **Lesión unilateral o sangrante** → **biopsia** (sospecha de tumor).
 7. **Montelukast** útil en pacientes asmáticos con pólipos.
-

Errores comunes

- Suspender el tratamiento tópico demasiado pronto.
 - Indicar antibióticos sin evidencia de infección.
 - No descartar neoplasia ante pólipo unilateral.
 - Abusar de corticoides sistémicos.
 - No tratar comorbilidades (asma, alergia).
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **poliposis nasal** es una inflamación crónica eosinofílica de la mucosa nasal y sinusal.
2. Se asocia con **asma** y **sensibilidad a aspirina** (tríada de Samter).
3. El **diagnóstico** se basa en clínica y endoscopía, confirmada por TAC.
4. El **tratamiento de elección** son los **corticoides tópicos nasales + lavados salinos**.
5. En casos refractarios, se utiliza **prednisona corta** o **cirugía endoscópica funcional**.
6. La **recurrencia** es frecuente y requiere manejo médico prolongado.
7. **Pólipo unilateral = sospecha oncológica → biopsia**.